Nguồn: sách "Quản lý Điều dưỡng trưởng khoa 2026", Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học (bản lưu Thư viện Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân), Bài 2, tr. 22–27. Chủ biên/tác giả, ISBN: chưa có thông tin. Nội dung chép nguyên văn; 3 sơ đồ vẽ lại theo bản in. Số hoá: Phòng Điều dưỡng, 31/10/2026.

Bài 2

CÁC MÔ HÌNH PHÂN CÔNG CHĂM SÓC

MỤC TIÊU

1. Trình bày được tiêu chuẩn đánh giá mô hình chăm sóc tốt.

2. Nhận biết được ưu điểm, nhược điểm các mô hình phân công chăm sóc.

1. ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH CHĂM SÓC TỐT

Nhằm thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện: mỗi người bệnh phải được một bác sĩ và một điều dưỡng chịu trách nhiệm cụ thể về điều trị và chăm sóc. Hiện nay có nhiều mô hình chăm sóc khác nhau, mỗi mô hình đều có những ưu điểm và nhược điểm của nó, tuy nhiên chọn lựa một mô hình phân công chăm sóc tốt phù hợp với cơ sở, điều đó còn phụ thuộc vào khả năng của điều dưỡng trưởng khoa. Song một mô hình chăm sóc tốt cần phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

1.1. Lấy bệnh nhân là trung tâm của bệnh viện

Nhu cầu của người bệnh vừa có tính đồng nhất và vừa có tính duy nhất, cho nên công tác chăm sóc phải lấy bệnh nhân là trung tâm và phải dựa vào nhu cầu cụ thể của từng người bệnh mà có các biện pháp chăm sóc thích hợp.

1.2. Tính liên tục trong chăm sóc

Việc chăm sóc cho một người bệnh trong thời gian nằm viện đòi hỏi sự tham gia của nhiều người, nên để đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc cần tổ chức tốt việc giao ban, báo cáo, bàn giao giữa các ca kíp, đồng thời phải phân công cho từng nhân viên điều dưỡng phụ trách một số bệnh nhân nhất định trong một thời gian dài, mà tốt nhất là từ lúc bệnh nhân vào viện cho đến ra viện, nhằm nắm chắc các diễn biến và tiến triển của từng bệnh nhân.

1.3. Phù hợp với đặc điểm chuyên môn và điều kiện từng khoa

Khi áp dụng một mô hình chăm sóc nào đó, điều dưỡng trưởng cần cân nhắc kỹ về tính chất bệnh nhân của khoa, xem xét các nguồn lực như con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí để chọn các mô hình chăm sóc thích hợp, vì nó có tác dụng trực tiếp đến chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

2. CÁC MÔ HÌNH PHÂN CÔNG CHĂM SÓC

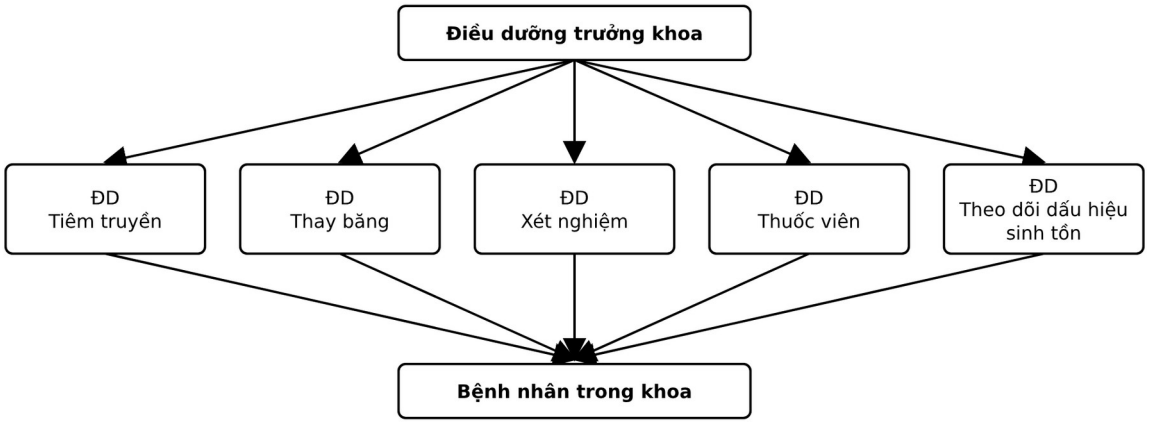
Nói đến chăm sóc sức khoẻ, chúng ta không thể không nhắc tới người điều dưỡng và nghề Điều dưỡng. Họ là lực lượng chính mang dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tới cộng đồng, tới vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người, vùng xa xôi hẻo lánh. Có thể nói, người đầu tiên đón em bé chào đời là người hộ sinh. Người nâng giấc, chăm sóc, an ủi người bệnh lúc đau yếu, những giờ phút cuối đời tại bệnh viện chính là người

điều dưỡng. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khoẻ do người điều dưỡng, hộ sinh cung cấp là trụ cột của Hệ thống y tế.

Có nhiều mô hình phân công chăm sóc khác nhau, mỗi mô hình đều có những ưu điểm của nó, tuy nhiên khi lựa chọn một mô hình chăm sóc cần căn cứ vào cơ sở, tình hình bệnh nhân cũng như tuỳ thuộc vào khả năng của từng người. Lựa chọn một mô hình chăm sóc phù hợp với cơ sở là một trong những nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa. Nó có tác dụng trực tiếp đến chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Một số mô hình sau có thể được áp dụng vào kế hoạch chăm sóc người bệnh.

2.1. Mô hình phân công chăm sóc theo nhiệm vụ

Mô hình phân công chăm sóc theo nhiệm vụ, đó là một điều dưỡng có thể thực hiện 1 hoặc 2 nhiệm vụ chăm sóc trên một nhóm bệnh nhân hoặc toàn bộ bệnh nhân trong khoa, dưới sự điều khiển của điều dưỡng trưởng khoa. Đây là một mô hình chăm sóc lấy nhiệm vụ làm trọng tâm, tất cả các điều dưỡng trong đơn vị đều tham gia công tác chăm sóc bệnh nhân trong khoa. Tuy nhiên mô hình chăm sóc theo nhiệm vụ hiện nay ít được khuyến khích áp dụng vào thực tế, vì nó không thích hợp cho công tác chăm sóc bệnh nhân và đến nay đã có nhiều bệnh viện bỏ hẳn mô hình này.



Sơ đồ 2.1: Mô hình chăm sóc theo nhiệm vụ

2.1.1. Ưu điểm

– Phù hợp khi có cấp cứu hàng loạt.

– Bệnh nhân lưu, nằm viện ngắn ngày.

– Đòi hỏi phương tiện tối thiểu.

2.1.2. Nhược điểm

– Điều dưỡng lấy nhiệm vụ thay vì lấy bệnh nhân làm trung tâm, nên bệnh nhân không được đáp ứng các nhu cầu riêng biệt.

– Các nhiệm vụ hướng về điều trị hơn là chăm sóc.

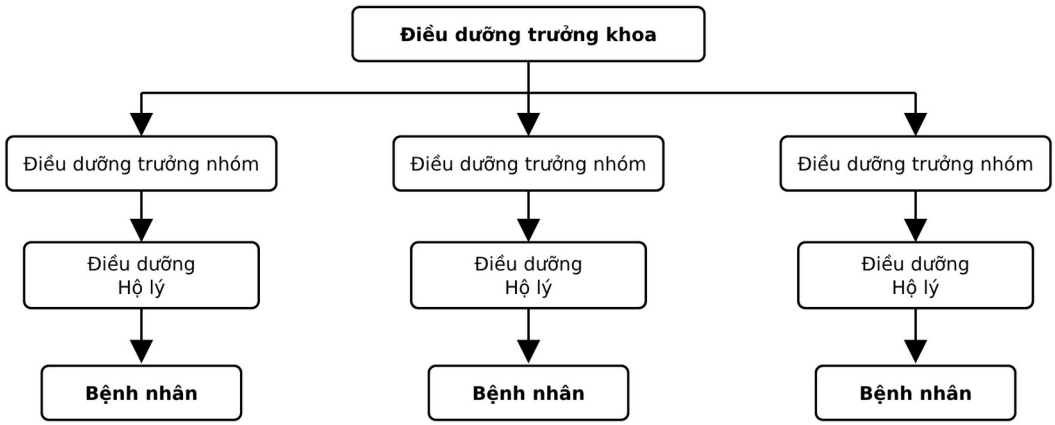
– Công việc được thực hiện trên một bệnh nhân riêng lẻ, thiếu tính liên tục.

– Mỗi điều dưỡng nắm một phần công việc, không có ai nắm được toàn trạng bệnh nhân trong quá trình chăm sóc.

– Nhân viên cảm thấy buồn tẻ vì công việc đơn điệu và không phát huy hết khả năng của mỗi điều dưỡng.

2.2. Mô hình phân công chăm sóc theo nhóm

Mô hình phân công chăm sóc theo nhóm là chăm sóc cho một nhóm bệnh nhân được thực hiện bởi một điều dưỡng, dưới sự điều khiển của điều dưỡng trưởng nhóm, mô hình này cũng hay được áp dụng. Mô hình phân công chăm sóc theo nhóm đáp ứng được tiêu chí lấy người bệnh làm trung tâm chăm sóc không chỉ dịch vụ y tế mà còn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người bệnh cả về thể chất, tinh thần và xã hội. Mô hình phân công chăm sóc theo nhóm phù hợp với điều kiện tại bệnh viện.



Sơ đồ 2.2: Mô hình chăm sóc bệnh nhân theo nhóm

2.2.1. Ưu điểm

– Điều dưỡng nắm được diễn biến chung của bệnh nhân và chịu trách nhiệm đối với bệnh nhân mà mình phụ trách.

– Điều dưỡng viên nêu cao được tinh thần trách nhiệm và tính sáng tạo trong công việc.

– Thông tin giữa các nhóm viên với bác sĩ và bệnh nhân thường xuyên hơn.

– Công việc chăm sóc đỡ buồn tẻ và manh mún.

– Giao tiếp giữa điều dưỡng, bệnh nhân và gia đình được dễ dàng hơn, đặc biệt là những tâm tư rất tế nhị của người bệnh.

– Điều dưỡng trưởng khoa có thời gian để giám sát và giảng dạy.

2.2.2. Những yếu tố cần thiết để áp dụng

– Nhóm trưởng cần có kỹ năng về chuyên môn và điều hành.

– Nhóm trưởng chịu trách nhiệm chung về chăm sóc, quản lý buồng bệnh và dụng cụ được giao.

– Cần trao đổi thông tin về bệnh nhân giữa các thành viên trong nhóm thường xuyên.

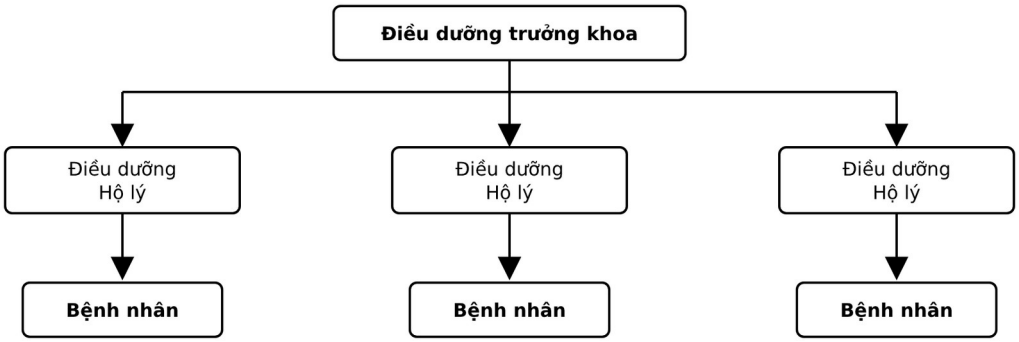
– Điều dưỡng trưởng khoa phải chịu trách nhiệm chung về kế hoạch nhân lực và điều chỉnh nhân lực giữa các nhóm.

– Điều dưỡng trưởng khoa cần tăng cường kiểm tra và hỗ trợ cho các nhóm trưởng khi có yêu cầu.

– Yêu cầu phải có đầy đủ nhân lực và cơ sở vật chất.

2.3. Mô hình chăm sóc toàn diện

Mô hình chăm sóc toàn diện là một điều dưỡng được phân công chăm sóc toàn diện cho một số bệnh nhân trong một giai đoạn nhất định. Đó là từ khi bệnh nhân vào viện cho đến khi bệnh nhân ra viện đều do một điều dưỡng chịu trách nhiệm chăm sóc chính. Số lượng bệnh nhân được phân công chăm sóc phụ thuộc vào tình hình bệnh tật, cũng như phụ thuộc vào tính chất của bệnh, tuy nhiên thông thường số lượng khoảng từ 5 đến 7 bệnh nhân cho 1 điều dưỡng trực tiếp chăm sóc toàn diện. Mô hình này hiện nay đã được nhiều nơi áp dụng và đã cho kết quả chăm sóc bệnh nhân tốt. Trong mỗi nhóm điều dưỡng chăm sóc do điều dưỡng trưởng nhóm có trình độ tay nghề vững vàng quản lý, chịu trách nhiệm lập kế hoạch chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân trong nhóm, hướng dẫn điều dưỡng trong nhóm thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh. Điều dưỡng chăm sóc đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người bệnh cả về thể chất, tinh thần và xã hội theo phân cấp chăm sóc. Hướng dẫn thân nhân người bệnh cùng chăm sóc.



Sơ đồ 2.3: Mô hình chăm sóc bệnh nhân toàn diện

2.3.1. Ưu điểm

– Mỗi bệnh nhân đều có 1 điều dưỡng chịu trách nhiệm chăm sóc chính.

– Điều dưỡng theo dõi và chăm sóc bệnh nhân liên tục.

– Giao tiếp giữa điều dưỡng, bệnh nhân và gia đình được dễ dàng và thoải mái hơn, đặc biệt là những tâm tư rất tế nhị của người bệnh.

– Điều dưỡng phát huy hết khả năng chăm sóc người bệnh.

– Điều dưỡng cũng luôn nâng cao trách nhiệm phục vụ người bệnh, tinh thần chịu khó tìm tòi học hỏi và nghiên cứu để nâng cao chất lượng chăm sóc.

2.3.2. Những yếu tố cần thiết để áp dụng

– Nhân viên điều dưỡng phải có đủ trình độ, kỹ năng và thái độ cần thiết.

– Những điều dưỡng còn yếu về chuyên môn không đủ khả năng chăm sóc toàn diện, điều dưỡng trưởng cần phân công kèm cặp hoặc giám sát hỗ trợ thường xuyên.

– Có đầy đủ phương tiện và dụng cụ cần thiết.

– Đảm bảo nhân lực hàng ngày ổn định.

– Điều dưỡng trưởng khoa cần tăng cường công tác huấn luyện kỹ năng, chuyên môn và công tác kiểm tra đối với các nhân viên điều dưỡng, đồng thời thường xuyên đi buồng cùng với bác sĩ điều trị cũng như bác sĩ trưởng khoa để nắm tình hình bệnh nhân, nhằm bổ sung vào công tác chăm sóc kịp thời.

Vì vậy lựa chọn một mô hình chăm sóc phù hợp là một trong những nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa. Nó có tác dụng trực tiếp đến chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Mô hình chăm sóc theo nhiệm vụ ít được khuyến khích áp dụng vào thực tế, vì nó không thích hợp và đến nay đã có nhiều nơi người ta bỏ hẳn mô hình chăm sóc theo nhiệm vụ.

Các bệnh viện đang từng bước có sự chuyển hướng và áp dụng dần mô hình chăm sóc theo nhóm và tiến tới chăm sóc toàn diện, vì nó là một trong những khâu quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

PHỤ LỤC (Phòng Điều dưỡng bổ sung, không thuộc bản gốc)

Bảng so sánh nhanh 3 mô hình

Tiêu chí	Theo nhiệm vụ	Theo nhóm	Toàn diện
Trọng tâm	Nhiệm vụ, kỹ thuật	Nhóm người bệnh	Từng người bệnh
Người chịu trách nhiệm NB	Không rõ một người	ĐD trưởng nhóm	1 ĐD chăm sóc chính (5–7 NB/ĐD)
Tính liên tục	Thấp	Trung bình – khá	Cao (vào viện đến ra viện)
Phù hợp khi	Cấp cứu hàng loạt, NB lưu ngắn ngày, phương tiện tối thiểu	Đủ nhân lực, có nhóm trưởng vững chuyên môn và điều hành	ĐD đủ trình độ, nhân lực hằng ngày ổn định, đủ phương tiện
Khuyến nghị của tài liệu	Ít khuyến khích, nhiều nơi đã bỏ	Áp dụng dần	Hướng tới

Liên hệ áp dụng tại BV Đa khoa Nhật Tân

– Tiêu chí C6.3 (Người bệnh được chăm sóc toàn diện) trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện: dùng bài này làm tài liệu tập huấn nền cho hồ sơ C6.3 (Quy định chăm sóc toàn diện QĐ-C6.3, SOP-C6.3-01 nhận định, phân cấp, kế hoạch chăm sóc).

– Căn cứ hiện hành về chăm sóc điều dưỡng: Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện (thay Thông tư 07/2011/TT-BYT). Số hiệu và hiệu lực: Cần xác minh trước khi trích dẫn trong văn bản chính thức.

– Tỷ lệ 5–7 người bệnh/1 điều dưỡng là số liệu của tài liệu gốc, không phải định mức pháp lý; định mức nhân lực theo văn bản hiện hành: Cần xác minh.

– Thuật ngữ: sách gốc dùng “bệnh nhân”, văn bản của Bệnh viện dùng “người bệnh (NB)”; “hộ lý” trong sơ đồ tương ứng nhân viên hộ lý/chăm sóc hiện nay.